

Fecha Última Actualización: 07-04-2022 13:23:57

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Ana Rosa Díaz Heredia

Edad : 57a 5m 12d

Dirección : Estero Pedregozo 665 Mamiña li

Rut : 10.627.255-7

Fecha Nacto: 26/10/1964

Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1509007

Sexo : Femenino

Teléfono : 9 5051 7136

N° Epicrisis

299625

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 22/02/2022 21:39

Días Estadía: 44

Unidad de Egreso : Neurología / Neurocirugía

Fecha Egreso : 07/04/2022 09:04

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Sd. convulsivo

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Fecha Ingreso UPC: 25/02/22

Fecha Ingreso UTIM: 12/03/22

Fecha de Ingreso sala de neurología: 16/03/22

Paciente de 57 años, Diestra, mRankin 1 con los siguientes antecedentes:

- Antecedentes mórbidos: Lumbago mecánico, artrosis, COVID febrero 2022, trastorno por uso de sustancias
- Antecedentes quirúrgicos: desconocidos
- Medicamentos: (-)
- Alergias: (-)
- Hábitos: TBQ (+), OH (+), cocaína (+)
- Inmunizaciones: COVID 3 dosis
- Social: auxiliar de aseo en colegio, educación media completa. Vive con esposo e hijo.

Historia de ingreso HSR:

Paciente, con antecedentes mencionados, aproximadamente desde el 16/02/2022 inicia con cuadro clínico caracterizado por cefalea, mialgias, dolor abdominal, fiebre, el 21/02/2022 consulta en atención primaria en salud por dichos síntomas y es enviada a domicilio con tratamiento sintomático con respuesta parcial a los síntomas, el 22/02/2022, según refiere esposo, mientras consuma cocaína presentó convulsiones tónico clónicas por siete ocasiones, acude en ese contexto a atención primaria en salud, según dato de atención de SAPU Sapu-Karol Wojtyla ingresó febril, consciente, orientada, se interpreta el cuadro como infección por SARS COV 2.

Fue derivada a este centro asistencial, en donde ingresó al servicio de urgencia el mismo 22/02/2022, en malas condiciones generales, con deterioro del estado de conciencia: apertura ocular al dolor, verbal: sonidos incomprensibles, respuesta motora dudosa. Fue evaluada por neurólogo de turno destacando paciente en sopor profundo, sin respuesta a amenaza visual, con RFM presente, retirando 4 extremidades al estímulo nociceptivo con fuerza al menos M3, sin signos de irritación meníngea. Se decidió iniciar cobertura antibiótica meníngea con Ceftriaxona, Ampicilina y Aciclovir. Al mismo tiempo se solicitó estudio con TC de cerebro que evidenció hipodensidad temporal derecha, con este resultado se realizó punción lumbar ese mismo día con proteínas 0.79, Glucosa 77 (HGT:121), Leucocitos: 110 predominio MN 87%.

La paciente el 23/02/2022 evolucionó con mayor compromiso de conciencia, requiere intubación orotraqueal y conexión a asistencia ventilatoria mecánica.

El 24/02/2022, se rescató PCR (film array) en LCR positivo para herpes virus tipo 1, se mantuvo tratamiento con aciclovir

Fecha Epicrisis : 07/04/2022 13:23

Página 1 de 4

intravenoso.

Ingres a UCI para continuar manejo.

Diagnósticos de Ingreso:

- Encefalitis herpética.
- Infección por COVID - 19 (PCR positivo 21/02 en extrasistema)

Evolución UPC-UTIM:

1. Hemodinamia/CV: Se mantuvo con requerimientos de NAD a dosis bajas en contexto de sedación. Clínicamente bien perfundida con DVA ya suspendidas, evolucionó sin conflicto.

-Angio TC TAP del 02/03: Tep segmentario bilateral + área de infarto pulmonar en LID, sin compromiso de cavidades derechas, desde entonces anticoagulada con HBPM, se mantiene sin conflicto hemodinámico. Se asoció TEP de riesgo intermedio-provocado en contexto de Covid reciente (febrero 2022 y TVP no oclusiva peri catéter en Vena yugular interna derecha).

2. Respiratorio: Paciente ingresó a UPC con compromiso de conciencia que requirió IOT y VMI. Logró progresar weaning posterior a repunte de conciencia. Estuvo 17 días en VMI, día viernes 11-03 con PaFi 364 previo a extubación se logra extubación a las 07:20 de la mañana sin incidentes, requiriendo soporte de O2 por naricera, posteriormente pase a CNAF dependiente de flujo del 12/03-13/03, broncorreica, secreciones mucopurulentas, sin embargo con buen fuelle ventilatorio, se logró suspender O2 el 14/03, consolidando weaning satisfactoriamente. Buena respuesta a manejo kinésico respiratorio logrando mejor aclaramiento y movilización de secreciones bronquiales.

TC Torax simple del día 14/03/22: relleno alveolar en LID sin consolidación categórica + leve derrame pleural bilateral que condicionó atelectasias pasivas.

3. Neurológico: Ingresó por compromiso de conciencia en contexto de encefalitis, inicialmente en tratamiento con ceftriaxona, ampicilina y dexametasona a la esperade estudio de LCR. Se inició levetiracetam y se solicitó electroencefalograma (EEG) que resultó con patrón de descargas periódicas lateralizadas a derecha, atenuación relativa de voltaje hemisférica derecha y disfunción lenta continúa generalizada. Se obtuvo PCR de VHS I (+) en LCR por lo que se suspendió tratamiento antibiótico y dexametasona, manteniendo solamente aciclovir.

EEG del 26/03 mostró muy frecuente actividad epileptiforme interictal central bilateral sincrónica e independiente a derecha, en ocasiones de aparición periódica, frecuentes depresiones generalizadas de voltaje y disfunción lenta continúa generalizada por lo que se inició fenitoína y se aumentó dosis de levetiracetam. TC de cerebro con necrosis hemorrágica temporal derecha y signos de sinusitis crónica por lo que se inicia tratamiento con ampicilina-sulbactam con mala respuesta, por lo que se escala a meropenem+vancomicina. TAC de cerebro de control 01/03 descartó sangrado activo.

Posterior inicio de fenitoína presentó alteración de pruebas hepáticas con patrón colestásico, por lo que el 02/03 se inició reducción gradual de fenitoína y se agrega diazepam.

Nuevo EEG del 05/03 con muy frecuente lentitud intermitente delta rítmica generalizada y a derecha y DLGG, por lo que se disminuye dosis de diazepam. Por parámetros inflamatorios a la baja se decide suspensión de ATB el 07/03. El 11/03 completó 14 días de aciclovir de forma satisfactoria.

En contexto de somnolencia post administración de diazepam se decidió suspenderlo. Sin nuevas crisis convulsivas. Evolucionó con delirium mixto.

4. Infeccioso: Completó tratamiento con Aciclovir por 14 días hasta el 11/03/22 por encefalitis herpética con evolución satisfactoria desde el punto de vista neurológico. Desde el punto de vista del estudio etiológico, impresionó ELISA VIH (-) sin otros estudios de inmunosupresión. TC Maxilo Facial del 14/03/22 sin evidencia de SNPS. TC TX del 14/03 que descartó focos de condensación neumónico.

Evolucionó subfebril, sin compromiso hemodinámico, con parámetros inflamatorios bajos. Estudio microbiológico:

- 12/03 HMC periféricos (-). EO inflamatorio, UC E. Coli BLEE. PCR COVID (-)
- 15/03 HMC (-). Se rescata resultado de UC y se inicia manejo antibiótico con Amikacina.

5. Renal/Medio interno: Se mantuvo con volemicación en contexto de tratamiento con aciclovir y evolucionó con parámetros de función renal y diuresis dentro de rango durante estadía hospitalaria.

6. Nutrición: Retiro de SNG post-extubación, evaluada por equipo de fonaudiología con disfagia severa (FILS 2).

7. Profilaxis: Paciente cursando TEP en tratamiento con HBPM en dosis plena. Se mantuvieron IBP. Colchón antiescaras, prevención de UPP.

Evolución en sala de Neurología:

1.- Neurológico: Paciente fue trasladada al servicio de neurología el 16/03 para continuar rehabilitación, evolucionó estable inicialmente con abulia marcada, que mejoró de forma progresiva. Desde ingreso a se ha mantenido tratamiento con levetiracetam 1.5 gr cada 12 hrs, sin eventos sugerentes de crisis. Se mantuvo sin agitación psicomotora.

Neurorrehabilitación:

- Fonoaudiología: con disfagia severa FILS 2, con mal pronóstico de deglución por lo que se tramitó GTT. Realizada el día 31/03 sin incidentes.
- Terapia ocupacional: paciente con postura cervical anormal, con indicación de uso de cojín cervical a tolerancia.
- Kinesioterapia: Transición a SBC con maxima asistencia de 1 persona. Transición a bípedo con asistencia leve de 1 persona desde EESS por anterior, bipedo inestable con asistencia desde anterior por 1 persona.

2.- Infectología:

Ingresó con amikacina por ITU por e coli BLEE, finalizó tratamiento el 18/03. Posteriormente presentó fiebre y leucocitosis, se realizó el siguiente estudio infectológico:

- Sedimento de orina inflamatorio con 45 leucocitos por campo y bacterias abundantes
- Hemocultivos (+) Staphylococcus epidermidis sensible a vancomicina
- Urocultivo 21/03 (+): 100.000 UI enterococcus faecium Van B resistente a vancomicina.

Tras informe de hemocultivos positivos para cocáceas Gram (+) se indicó inicialmente vancomicina. Tras resultado de urocultivo se solicitó evaluación por infectología que dado resultado de urocultivo con antibiograma de enterococcus faecium y hemocultivos positivos muy tardíos, sugirió suspender vancomicina e iniciar Linezolid 600 mg cada 12 h para completar 7 días (FI: 26/03). Evolucionó sin nuevos peaks febriles y con PCR a la baja.

3.- Urológico:

Se realizó retiro de sonda foley el 18/03 tras finalizar tratamiento con amikacina, sin embargo paciente evolucionó con requerimientos de sondeos cada 8 h por retención urinaria se reinstaló sonda foley el 23/03. Tras finalizar tratamiento antibiótico con imipenem se reintentó retiro de Sonda Foley, sin embargo, nuevamente con necesidad de sondeos, se reinstaló sonda Foley el 06/04

Actualmente se mantiene diuresis con sonda Foley.

Paciente en condiciones actualmente para continuar neurorrehabilitación en Policenter

Diagnóstico de Egreso

Ecefalitis Herpética Tratada - Vhs 1
Infección Urinaria - Enterococcus Faecium Van B Resistente A Vancomicina
Retención Urinaria -
Disfagia Severa Fils 2 -
Trastorno De La Marcha -
Trastorno Por Abuso De Sustancias -
Tep Segmentario Bilateral - En Tratamiento Anticoagulante (Hbpm)

Condición de Egreso Alta Derivado al Hospital San José de Maipo

Egreso con Catéter Doble J: NO

SV: PA 121/75 mmHg, FC 85 lpm, Sat 95% ambiental, T° 36.3°C

- Hidratada, bien perfundida
- RR2T no ausculto soplos
- MP (+) SRA
- Abdomen BDI, RHA (+) no palpo masas ni visceromegalias
- EEII sin edema, sin signos de TVP

Neurológico

- Vigíl, desorientada en tiempo y espacio. Inatenta. Nomina 5/5 y repite 5/5. Obedece ordenes simples de manera inconsistente. Disartria leve e hipofónica severa.
- PC: isocoria, RFM (+/+), campo visual conservada por amenaza, OCM impresiona conservada, PFC izquierda leve, resto impresiona sin alteraciones.
- Motor: paratonía leve. Trofismo conservado. Fuerza: al menos M4 en las 4 extremidades. ROT presentes y simétricos.

Fecha Epicrisis : 07/04/2022 13:23

- Plantares flexores. Clonus (-).
- Sensitivo: impresiona conservado.
 - Cerebreloso no coopera.
 - Impresiona sin signos meningeos.

Plan Post Alta

Generales:

- Reposo: absoluto, movilizar por kinesiología.
- Régimen: fresubin 60 cc/hr por GTT + 20 cc7hra de agua libre por GTT.
- Rehabilitación: kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional.

Medicamentos:

- Enoxaparina 80 mg, 1 ampolla cada 12 hrs por vía SC.
- Levetiracetam 500 mg, 3 comprimidos cada 12 hrs por GTT.
- Omeprazol 20 mg, 1 comprimido al día por GTT.
- Paracetamol 500 mg, 2 comprimidos en caso de dolor o fiebre (máximo cada 8 hrs) por GTT.
- PEG 15 gr en 200 cc de agua cada 12 hrs por GTT.
- Bromuro de ipratropio, 2 puff cada 6 hrs con aerocámara.

Pendientes:

- Iniciar traslape a tratamiento anticoagulante oral (TACO), por diagnóstico de TEP bilateral.

Controles médicos:

- Control con neurología en CDT pasillo 9, en 2-3 semanas. Pedir hora con este documento (epicrisis).
- Control con urología en CDT pasillo 9, solicitar hora con interconsulta
- Control en CESFAM correspondiente para retiro de medicamentos. Presentar documentos entregados (GES e interconsulta).
- Consultar en servicio de urgencia en caso de síntomas de alarma.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Sebastian Escobar Diaz
Becado/Residente



Amada Marcela Espinosa Maramb
Médico Tratante (Staff)